

清除呼吸道異物 (>1 歲)

(一)輕度異物哽塞：

1. 立即詢問病人或家屬「病人噎到了嗎？」。
2. 鼓勵病人咳嗽，絕不要去干擾病人自發性的咳嗽和出力的呼吸。

(二)重度異物哽塞(病人清醒)：

1. 立即詢問病人或家屬「病人噎到了嗎？」。
2. 若病人點頭表示或無法發出聲音時，應立即在病人後面 5 次背部拍擊後，再移動到病人背後使雙腳成弓箭步、前腳膝蓋置於病人胯下、上半身靠近或貼緊病人背部以穩住病人。
3. 1 手握拳(大拇指與食指形成之拳眼面向肚子)放於上腹部正中線，位置於肚臍上緣，另 1 手抱住放好之拳頭(若無法實施腹部推擠應考慮胸部按壓，例如：懷孕後期或肥胖者)，進行 5 次腹部快速推壓。
4. 隨時留意是否有異物吐出，若無排除，持續 5 次背部拍擊與 5 次腹部快速推壓，直到病人意識喪失或異物被排除為止。若病人意識尚未尚失，且已執行約 4 回合(拍背及腹部推壓)仍無法將異物排除，應考慮送醫。

(三)若異物無法排除且病人意識喪失而癱在施救者身上時：

1. 弓箭步之前腳應往後退，小心迅速的讓病人仰躺於地上。
2. 打開病人的呼吸道，同時間若發現病人嘴內有可見的固體異物時，

應先將病人頭部側向一邊，實施手指清除。

3. 若已清除或無可見的固體異物時，給予吹氣 1 次。

4. 若氣吹不進去或胸部沒有升起時，重新打開呼吸道，再吹氣 1 次。

5. 若氣仍吹不進去或胸部沒有升起時，應立即給予胸部按壓 30 次(每分鐘 100~120 次之速度)，同時要目視是否有異物吐出或阻塞解除的現象。

6. 重複步驟 2~5，直到阻塞解除或已執行 5 循環按壓結束後仍未排除時，立即使用 AED 及 CPR 相關處置持續急救。

(四)操作當中發現異物被吐出或阻塞解除的現象時，除非目視病人已顯現出適當的呼吸外，應給予 2 次的吹氣，然後檢查脈搏。

註 1：若操作第 2 循環按壓（30 次）仍未排除哽塞時，副手應考慮使用 AED，待第 5 循環按壓結束後仍未排除時，立即使用 AED，操作過程中查看口中有無異物，並聽從 AED 指示操作，儘速離開現場送醫。

註 2：若急救過程異物已排出，病人仍沒有適當呼吸及脈搏時，繼續 CPR，同時另 1 人使用 AED 分析，適當處置後送醫。